



Trastornos disociativos

J. Camacho Rubio* y M.S. Olmeda García

Servicio de Psiquiatría. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Trastorno de identidad disociativo (TID)
- Despersonalización
- Amnesia
- Disociación

Keywords:

- Dissociative identity disorder (DID)
- Depersonalization
- Amnesia
- Dissociation

Resumen

Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de las distintas funciones mentales. Incluyen el trastorno de despersonalización-desrealización, la amnesia disociativa y el trastorno de identidad disociativo (TID). La teoría etiológica más aceptada los relaciona con eventos traumáticos, especialmente en forma de abuso o negligencia en la infancia de carácter grave y crónico. La disociación actúa como una protección inconsciente para no experimentar el dolor emocional que implican estos eventos. El diagnóstico es clínico y el diagnóstico diferencial incluye principalmente epilepsia, consumo de sustancias, trastornos neurocognitivos, psicóticos, afectivos, de personalidad, por estrés postraumático, facticio y simulación. No existe evidencia sólida de la eficacia de ningún tratamiento. El tratamiento del TID se orienta en fases: estabilizar síntomas; abordar memorias traumáticas; integrar y rehabilitar. La psicoterapia es la base del tratamiento. Los psicofármacos se emplean para facilitar la entrevista, estabilizar al paciente y tratar las comorbilidades.

Abstract

Dissociative disorders

Dissociative disorders are characterized by a disruption of and/or discontinuity in the integration of normal mental functions. Depersonalization/derealization disorder, dissociative amnesia and dissociative identity disorder (DID) are included in this category. The most accepted etiological theory relates them with severe and chronic traumatic, neglectful, and/or abusive events in childhood. So, dissociation protect the subject against emotional pain. Diagnosis is clinical. Epilepsy seizures, substances abuse, neurocognitive disorders, psychotic disorders, affective disorders, personality disorders, post-traumatic stress disorders and factitious and simulation disorders are mainly included in differential diagnosis. There is no solid evidence for effectiveness of any treatment. Management approach of DID encompass the following stages: symptom stabilization; address of traumatic experience memories; integration of consciousness functions and rehabilitation. The mainstay of treatment is psychotherapy. Psychotropic drugs are used in order to facilitate the interview, to stabilize the patient and to treat the comorbidities.

Concepto y clasificación

Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de la consciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. En resumen, pueden verse afectadas todas las áreas de funcionamiento psicológico¹.

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª edición) (DSM-5) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría¹ dedica un capítulo independiente para estos trastornos, que incluyen, obviando las categorías residuales, los siguientes:

1. Trastorno de despersonalización-desrealización.
2. Amnesia disociativa, que actualmente incluye la fuga disociativa como subtipo.
3. Trastorno de identidad disociativo (TID).

La Clasificación internacional de enfermedades (10ª edición) (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud² los denomina trastornos disociativos o de conversión y difiere del DSM-5 en que no incluye el trastorno de despersonalización.

*Correspondencia

Correo electrónico: javi_760@hotmail.com

zación-desrealización y, sin embargo, incluye el trastorno de conversión.

El síntoma que está detrás de todos esos trastornos es la disociación. Este es un mecanismo muy habitual que puede experimentarse de forma ocasional y transitoria. Todos hemos podido experimentar el haber llegado a nuestro destino realizando de forma adecuada todos los automatismos de conducir, sin haber sido conscientes de haberlo hecho porque nuestra mente «estaba en otro sitio»³.

El problema surge cuando este mecanismo se presenta de forma continua y desadaptativa. La disociación patológica es un fenómeno transdiagnóstico que no solo está presente en los trastornos disociativos, sino también en otros trastornos mentales como el trastorno límite de personalidad y el trastorno por estrés posttraumático (TEPT)¹.

Los síntomas disociativos pueden clasificarse en:

1. Positivos, experimentados como intrusiones en la consciencia y en el comportamiento, con pérdida de la continuidad en la experiencia subjetiva, como ocurre con la despersonalización, la desrealización y la fragmentación de la identidad.

2. Negativos, experimentados como incapacidad para acceder o controlar funciones mentales que previamente eran controlables, como ocurre en la amnesia disociativa¹.

Dentro de los trastornos disociativos, la disociación se presenta como un espectro de gravedad, pudiendo producirse de las siguientes formas:

1. Parcial, generando desapego y distanciamiento de las funciones mentales afectadas, como sucede en el trastorno de despersonalización-desrealización.

2. Completa, generando compartimentalización de las funciones mentales afectadas, como sucede en la amnesia disociativa y, en grado extremo, en el TID⁴⁻⁶.

Etiopatogenia

Modelo del trauma

La teoría etiológica más aceptada sobre los trastornos disociativos es el modelo del trauma, que relaciona la disociación con eventos traumáticos.

Generalmente, en psicología, se define a la disociación como un mecanismo psicológico que se pone en marcha de forma inconsciente para no experimentar el dolor emocional que padeceríamos cuando nos enfrentamos a una situación altamente conflictiva o estresante (trauma). Este mecanismo protege a la mente de la sobrecarga que supondrían estos acontecimientos y sus recuerdos, pero impide que la persona los pueda procesar e integrar.

Si esta disociación se experimenta de forma prolongada durante la infancia o la adolescencia, puede ocasionar un patrón de respuesta al estrés rígido y crónico que se mantiene en el tiempo, incluso cuando el acontecimiento traumático ha pasado, y que afectará intensamente a la capacidad de adaptación en los distintos ámbitos de la vida de la persona, ocasionándole un trastorno mental.

El trauma psicológico en forma de abuso o negligencia en la infancia de carácter grave y crónico se ha implicado en

el origen de la disociación, lo que sugiere una interacción compleja de predisposición (genética, neurobiológica y cognitiva) de vulnerabilidad y de eventos estresantes.

La disociación que aparece próxima al acontecimiento traumático (disociación peritraumática) puede considerarse un mecanismo de defensa adaptativo para hacer frente a una amenaza abrumadora que no se puede prevenir y de la que no se puede escapar. Aumentar la distancia interna sirve para disminuir emociones insoportables y reducir la consciencia del evento (despersonalización, desrealización, estupor disociativo) o distanciarse del propio cuerpo («verse desde fuera») para reducir la consciencia de las lesiones físicas. Aunque la disociación peritraumática sirve como defensa psicológica, se ha observado que aumenta el riesgo de trastornos mentales posteriormente, ya que la disociación interfiere con la codificación de acontecimientos y produce una fragmentación de la memoria⁷.

Características del trauma

La aparición de un trastorno disociativo se hace más probable cuando el evento traumático es precoz, grave, frecuente, violento (sobre todo físico o sexual) e interpersonal, especialmente si es llevado a cabo por los cuidadores⁸. La diferencia del TID con respecto al resto de trastornos disociativos parece ser la vivencia de eventos traumáticos que cumplen en mayor medida las características anteriores. En las diferentes series de estudios se encontró negligencia y/o abuso físico o sexual entre el 90-100% de los casos de TID^{9,10}.

Estilos de interacción con cuidadores

Es probable que los estilos de apego desorganizados favorezcan el desarrollo posterior de un TID¹¹. Bowlby¹² planteaba que las interacciones inadecuadas con los cuidadores primarios pueden llevar a que el niño desarrolle múltiples representaciones internas de sí mismo y de las figuras de apego. El apego desorganizado surge cuando el niño, que necesita cuidado y confort por parte del adulto, es aterrorizado por ese mismo cuidador, al que a la vez busca para que le calme. La figura de apego es segura y peligrosa a la vez¹³.

Sistemas de acción defensivos y sistema nervioso autónomo

Hay autores^{14,15} que encuentran una analogía entre estas respuestas y la de congelación de los animales ante un peligro inminente. En ellos, tras una primera activación simpática que favorecería los mecanismos de lucha o huida y ante la imposibilidad de llevarlos a cabo, se produciría una activación del sistema parasimpático y un apagado de la activación.

Modelo cognitivo

La construcción del *self* se lleva a cabo por la suma de experiencias vitales que se identifican como propias. Reúne recuerdos autobiográficos con consciencia autoconsciente (que implica reconocer las experiencias como propias, recordarlas y tener la certeza de haberlas experimentado)¹⁶.

Un rasgo aparente en las identidades disociativas se basa en el error en la codificación de acontecimientos vividos (memoria), así como en la percepción de propiedad de esas

experiencias. Hay una brecha entre el recuerdo y el sentido del *self*. Cada una de las identidades disociativas se siente propietaria de diferentes recuerdos, de diferentes aspectos del mismo recuerdo, o el recuerdo se asocia a diferentes narrativas o apreciaciones¹⁷.

Modelo sociocognitivo

Refieren que la influencia de los medios de comunicación, un alto nivel de reconocimiento social del trastorno, terapeutas carismáticos y la propia sugestionabilidad del paciente con sus distorsiones cognitivas y tendencia a la fantasía pueden conducirlo al fuerte convencimiento de padecer un TID. Estas hipótesis fueron apoyadas por autores escépticos que negaban la existencia del trastorno. Hoy en día no se sostienen, ya que hay gran evidencia acerca de la influencia del trauma en el origen de estos trastornos^{3,18}.

Neuroimagen

Las suposiciones teóricas y la investigación sugieren un vínculo entre los síntomas disociativos y las alteraciones en las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento de las emociones y la memoria (amígdala, hipocampo, giro parahipocampal y giro temporal medio y superior), atención y conciencia interoceptiva (ínsula), filtrado de la entrada sensorial (tálamo), procesos autorreferenciales (corteza cingulada posterior, precuneus y corteza prefrontal medial), control cognitivo y modulación de la excitación (giro frontal inferior, corteza cingulada anterior y corteza prefrontal lateral) pero aún no se han podido presentar resultados concluyentes^{19,20}.

Genética

El 50% de la varianza en el desarrollo de síntomas disociativos podría ser explicada por factores genéticos²¹.

Historia

La historia de la disociación y los trastornos disociativos se ha movido paralela al origen de la psiquiatría y la psicología modernas, aunque desde el principio han existido controversias que no se han resuelto por completo en la actualidad, y que han llevado a constantes cambios en su concepto y en su categorización³.

Junto con los trastornos conversivos, fueron considerados tradicionalmente formas de «neurosis histéricas».

El trastorno disociativo fue el trastorno más antiguo que se describió. Hasta 1800 las personas que lo padecían eran consideradas «poseídas». A principios del siglo XIX, Benjamin Rush realizó la primera descripción clínica³.

Los neurólogos Jean-Marie Charcot y Josef Babinsky pensaban que se trataba de una enfermedad neurológica, cuyo rasgo era la hipnotizabilidad y la sugestionabilidad.

Pierre Janet (1920) creía que las experiencias traumáticas eran el eje central de la histeria y los fenómenos disociativos. Desarrolló un modelo conceptual y psicoterapéutico que se ha mantenido hasta hoy²².

Sigmund Freud se interesó al principio por la disociación, centrándose posteriormente en la represión y renunciando a la idea de los recuerdos reprimidos de traumas sexuales infantiles reales a favor de las fantasías edípicas²³.

El interés por la relación trauma-disociación descrita por Janet desaparecería con este autor hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos psiquiatras comenzaron a observar una alta incidencia de síntomas disociativos en combatientes (amnesia y fuga disociativas)³.

En 1980, los denominados trastornos disociativos se adoptan como categoría diagnóstica en el DSM-III, suprimiéndose el concepto de histeria²⁴.

Manifestaciones clínicas

Trastorno de despersonalización-desrealización

Consiste en la vivencia persistente o recurrente de que su actividad mental, su cuerpo y su entorno están cualitativamente cambiados, hasta el punto de ser irreales, lejanos o automatizados. A pesar de la naturaleza dramática de esta experiencia, el paciente es consciente de la irrealidad del cambio².

Esta experiencia recibe el nombre de despersonalización cuando afecta a la vivencia respecto a uno mismo, y de desrealización cuando lo hace respecto al entorno, pudiendo aparecer en el trastorno ambas formas tanto en solitario como a la vez, de forma indistinta.

Las funciones mentales que pueden verse implicadas principalmente son:

1. Identidad: «no soy nadie»; experiencias de yo escindido, con una parte observadora y otra parte participante que llega a ser una experiencia extracorporal en su forma más extrema.
2. Sentimientos: baja emocionalidad, «sé que tengo sentimientos pero no puedo sentirlos».
3. Pensamientos: «mis pensamientos no parecen míos».
4. Cuerpo: entumecimiento de ciertas partes del cuerpo, hormigueos.
5. Conducta: «siento que actúo como un robot».
6. Percepción: entorno descrito como plano, tenue, distante, nublado, parecido a un sueño; alteraciones perceptivas subjetivas como visión borrosa, agudeza visual aumentada, visión en túnel, alteraciones en la distancia o el tamaño de los objetos, acentuaciones de los sonidos.

Puede experimentarse en momentos de estímulos emocionales muy intensos o de crisis vital de cualquier índole: felicidad extrema, enamoramiento, duelo, miedo o ira intensos.

Estas vivencias son similares a la pérdida de familiaridad presente en el *jamais vu* (cuando no hay recuerdo de haber visto antes un objeto conocido) y en el fenómeno contrario, *déjà vu* (cuando un objeto o experiencia desconocidos resultan familiares). Los pacientes presentan grandes dificultades

para describir sus síntomas, verbalizando miedo a volverse locos y expresando sentimientos de vergüenza.

Formas de inicio

Al principio suele acompañarse de ataques de pánico o uso de sustancias, para luego permanecer sin que estos se den. Suele comenzar en la juventud, siendo inusual a partir de los cuarenta años, debiendo descartarse causas orgánicas subyacentes en dichos casos¹.

Historia natural

Frecuentemente se cronifica. Un tercio de los pacientes presentan episodios separados, otro tercio presenta síntomas continuos desde el principio y el último tercio presenta al inicio episodios esporádicos para luego suceder de manera continua. La intensidad de la sintomatología puede aumentar o disminuir, con exacerbaciones coincidentes con situaciones estresantes, aunque parte de los pacientes refieren un nivel constante de intensidad¹.

Amnesia disociativa

Consiste en una incapacidad para recordar información autobiográfica (episódica), normalmente relacionada con eventos traumáticos, incompatible con olvidos ordinarios. Los subtipos son²⁵:

1. Localizada o circunscrita: olvida todo un período determinado (por ejemplo, durante una guerra).
2. Selectiva: olvida algunos eventos de un período determinado (por ejemplo, durante una guerra, solo los momentos en los que era enviado a combatir).
3. Generalizada: olvida todas las experiencias de la vida del individuo.
4. Continua: olvida todos los eventos desde un momento determinado hasta el presente.
5. Sistematizada: olvida cierto tipo de información (por ejemplo, la relativa a la familia o al trabajo).
6. Fuga disociativa: el paciente efectúa recorridos y viajes con un propósito o vaga desorientado. Sale de forma súbita de su hogar, con frecuencia tras un estrés intenso, como un conflicto marital o un desastre por un fenómeno natural. Algunos asumen una nueva identidad, llegando a presentarse con un nombre distinto y a desempeñar otro trabajo durante meses, aunque lo más común es que el viaje sea breve, durando entre horas y días.

Los subtipos más frecuentes son la amnesia localizada y la selectiva¹, presentando los pacientes en numerosas ocasiones una combinación de subtipos²¹.

La fuga disociativa se da más frecuentemente en el contexto de un TID¹.

La memoria afectada es la episódica o autobiográfica, estando respetadas normalmente la memoria procedimental (información requerida para llevar a cabo habilidades) y la anterógrada (capacidad para almacenar nueva información)²¹.

Formas de inicio

El comienzo de las amnesias más frecuentes, las localizadas y las selectivas, suele pasar desapercibido. Normalmente los

propios pacientes no son conscientes de su amnesia hasta que las circunstancias les confrontan con el hecho de que han perdido información autobiográfica, por ejemplo cuando los demás les preguntan acerca de eventos que no pueden recordar¹.

Historia natural

Algunos episodios se resuelven rápidamente, por ejemplo cuando desaparece la situación estresante (sería el caso de una persona que se retira del combate), mientras que otros persisten durante largos períodos de tiempo. La fuga disociativa es especialmente resistente al tratamiento.

La memoria que se recupera puede ser experimentada en forma de *flashbacks*, pudiendo iniciarse un TEPT que se alterna con una amnesia sobre el contenido de esos *flashbacks*, generando considerable angustia.

Las conductas suicidas son frecuentes, especialmente cuando la amnesia remite de repente y la memoria oprime al individuo con recuerdos intolerables¹.

Trastorno de identidad disociativo

Algunos autores¹⁸ lo han definido como estados de personalidad diferenciados que son experimentados por el propio paciente o por los demás como diferentes en cuanto a edad, género, orientación sexual y habilidades. Cada estado presenta un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno y de sí mismo. Se han descrito una media de entre cinco y diez identidades simultáneas.

Anteriormente recibía el nombre de trastorno de personalidad múltiple. En la actualidad, parece más acertado hablar de una fragmentación de la identidad, o una discontinuidad en la memoria y en la identidad que el paciente experimenta como intrusiones en la consciencia debido a superposición, cambio o interferencia entre los estados, en lugar de alternancia de personalidades distintas²⁶.

Cuenta con los diferentes síntomas que aparecen en el resto de trastornos disociativos (amnesia con o sin fuga, despersonalización, desrealización), siendo el trastorno paradigmático de este grupo. De hecho, para el diagnóstico de TID, se requiere la presencia de amnesia disociativa que se explica por la amnesia que presentan unas identidades respecto a las otras¹.

También comparte síntomas con el trastorno de estrés postraumático. Principalmente se trata de *flashbacks*, durante los cuales reviven un evento anterior (tanto del acontecimiento traumático como de hechos cotidianos de identidades alternativas) como si estuviera ocurriendo en el presente, a menudo acompañando a un cambio de identidad, con amnesia posterior del contenido del *flashback*¹.

Los pacientes pueden presentar síntomas psicóticos transitorios. Por ejemplo, muchos refieren alucinaciones auditivas en forma de voces que le dan órdenes, presentes de forma crónica desde la infancia. Estas alucinaciones han sido conceptualizadas como manifestación de la comunicación entre los estados de personalidad. Normalmente no responden a la medicación antipsicótica.

Estos pacientes presentan fluctuaciones rápidas del estado de ánimo debidas a los síntomas de intrusión, la desregulación afectiva y el cambio o la interferencia entre los estados de personalidad²⁷.

Formas de inicio

Puede comenzar casi a cualquier edad de la vida. El inicio suele tener lugar durante la niñez^{1,18}.

Historia natural

No hay estudios sistemáticos prospectivos sobre el curso del trastorno. Ha sido descrito como crónico, fluctuante, con períodos de mayor o menor sintomatología y repercusión funcional¹⁸.

La manifestación o no de los estados de personalidad varía en función del nivel de estrés, la cultura, los conflictos internos y la tolerancia emocional del paciente, con una variación muy amplia del deterioro en el funcionamiento. La mayoría de los pacientes sin vivencias de posesión no muestran abiertamente la discontinuidad de su identidad¹. Solo una pequeña minoría presenta una alternancia clínicamente observable entre las identidades, al contrario de la imagen estereotipada del trastorno difundida en los medios de comunicación.

Entre el 92 y el 100% de los pacientes presentan ideación autolítica y del 66 al 80% han llevado a cabo un intento de suicidio¹⁸.

El trastorno tiende a la cronificación, siendo muy lenta y difícil la respuesta al tratamiento. Se asocia con peor pronóstico: el abuso continuo, la retraumatización posterior, la comorbilidad con trastornos mentales y enfermedades somáticas graves y el retraso en el tratamiento¹.

A medida que se produce la integración de las identidades, disminuye la sintomatología del paciente; sin embargo, las comorbilidades se hacen más sintomáticas²⁷.

Diagnóstico

Una buena entrevista clínica y un diagnóstico diferencial cuidadoso generalmente pueden conducir al diagnóstico correcto.

El proceso diagnóstico debe incluir un esfuerzo para evaluar el historial de traumas del paciente. Sin embargo, debido a su amnesia disociativa, los pacientes con TID a menudo proporcionan una historia fragmentada e incoherente al inicio del tratamiento. Hay que ser prudentes acerca de la presión ejercida en la entrevista para obtener detalles sobre el trauma, porque puede ser abrumador para la persona.

La falta de formación del clínico, unido a la presencia de muchos otros síntomas no relacionados con el trauma, lleva a errores diagnósticos y a centrar el tratamiento solo en los síndromes comórbidos.

Se recomienda la utilización de instrumentos psicométricos para medir la disociación²⁷.

En la tabla 1 se presentan los criterios diagnósticos de los trastornos disociativos.

Diagnóstico diferencial

Epilepsia

Los individuos con síntomas disociativos pueden presentar síntomas similares a los que se dan en las crisis parciales complejas del lóbulo temporal. Las personas con trastornos convulsivos pueden mostrar un comportamiento complejo, con amnesia durante las convulsiones y/o posteriormente durante el período postictal, pudiendo iniciar un vagabundeo errático, sin propósito, limitado al período de la actividad convulsiva. La electroencefalografía permite discriminar entre ambos diagnósticos¹.

Consumo de sustancias

Las sustancias que en mayor medida se relacionan con la aparición de síntomas de despersonalización-desrealización son la marihuana, los alucinógenos, la ketamina, el éxtasis y la salvia. En aproximadamente el 15% de los casos de trastorno de despersonalización-desrealización, los síntomas precipitan por la ingesta de sustancias; solo en el caso de que

TABLA 1

Criterios diagnósticos de los trastornos disociativos en forma de diagnóstico diferencial

	Trastorno de despersonalización-desrealización	Amnesia disociativa	Trastorno de identidad disociativo
Función mental afectada	Cualquiera	Memoria	Identidad y memoria
Vivencia o manifestación principal	Irrealidad o distanciamiento de uno mismo o del entorno	Incapacidad para recordar información autobiográfica (eventos traumáticos)	Dos o más identidades diferenciadas, con discontinuidad entre ellas. Incapacidad para recordar información autobiográfica (sucesos cotidianos y/o eventos traumáticos)
Forma de presentación temporal	Episodios recurrentes o persistentes de despersonalización-desrealización	Episodio persistente de amnesia	Episodios recurrentes de discontinuidad en la identidad y de amnesia
Compatibilidades	No puede tener causa médica		
	No puede producirse por efecto de sustancias		
	Incompatible con otro trastorno psiquiátrico que explique mejor la alteración (por ejemplo, otro trastorno disociativo, trastorno de estrés postraumático)		Se requiere amnesia disociativa. Puede cursar con despersonalización, trastorno de estrés postraumático y síntomas psicóticos
Juicio de realidad	Conservado		Conservado la mayor parte del tiempo
Repercusión clínica y social	Malestar y/o deterioro significativo		Malestar y/o deterioro significativo. No es una práctica cultural aceptada ni juegos de fantasía

Adaptada de *American Psychiatric Association*¹.

persistan durante un tiempo relativo posterior al consumo de sustancias puede realizarse dicho diagnóstico.

En la intoxicación con alcohol o benzodiacepinas puede haber episodios de amnesia (en el caso del alcohol se conocen como *blackouts*). Si la amnesia solo se produce en el contexto de consumo de sustancias o medicamentos, no podríamos establecer el diagnóstico de trastorno disociativo¹.

Trastornos neurocognitivos

Principalmente *delirium*, demencia y lesión cerebral por traumatismo. En ellos está afectada, aparte de la memoria episódica o autobiográfica, la procedimental y la anterógrada de forma irreversible; además de otras funciones mentales como el lenguaje, la orientación y la atención. Pueden presentar también signos neurológicos.

Trastornos psicóticos

El trastorno de despersonalización-desrealización se diferencia de los trastornos psicóticos en que el juicio de realidad se encuentra conservado, no hay alucinaciones ni ideas delirantes acerca de la sintomatología, que es frecuentemente descrita con la expresión «como si» (mientras que en la psicosis se expresa con certeza).

La despersonalización como síntoma puede estar presente en la esquizofrenia, siendo un fenómeno que con frecuencia precede incluso en años a la aparición de la psicosis. Se ha evidenciado que en numerosas ocasiones los delirios de los trastornos psicóticos están basados en experiencias de despersonalización previas, existiendo una transición fluida entre la despersonalización típica y la interpretación delirante de las mismas^{28,29}.

El TID puede presentar síntomas psicóticos similares a los presentados en los trastornos psicóticos (principalmente esquizofrenia), aunque con diferencias en sus características (tabla 2), siendo complicado en numerosas ocasiones el diagnóstico diferencial al inicio del cuadro, requiriéndose una larga observación longitudinal¹⁸.

Trastornos afectivos

En el TID, los pacientes pueden presentar síntomas de depresión o de manía pero, en general, no cumplen todos los criterios de episodio depresivo mayor o de episodio maníaco, siendo fluctuantes en el afecto y en la cognición, al aparecer en algunos estados de identidad pero no en otros.

Es frecuente que las fluctuaciones del ánimo se confundan con un trastorno bipolar tipo II. En el TID, los cambios son relativamente rápidos, a diferencia de lo que ocurre en las personas con un trastorno afectivo, cuyas fluctuaciones son más progresivas y no tan reactivas a estímulos ambientales, permaneciendo dichos estados durante mayor tiempo^{1,18}.

Trastornos de personalidad

Tanto el TID como el trastorno límite de la personalidad presentan alteraciones en la identidad. En el primer caso, consisten en una fragmentación de la identidad, con la presencia de varias identidades, con amnesia de unas respecto a las otras. En el segundo, hay una única identidad pero esta es inestable, con cambios repentinos en la autoimagen, las metas y los valores personales³⁰.

Trastornos de síntomas neurológicos funcionales (trastorno de conversión)

Son frecuentes en el TID, en cuyo caso no se hace el diagnóstico de trastorno de conversión, ya que para ello es necesario que los síntomas corporales no sean atribuidos a cambios de personalidades ni a experiencias de posesión. La amnesia disociativa en el trastorno de conversión está muy circunscrita, limitada por ejemplo, al episodio de convulsiones no epilépticas.

Trastorno por estrés postraumático

Comparte con el TID los síntomas de amnesia, *flashback*, intrusión, evitación e hiperactivación. Hasta el 79% de los pa-

TABLA 2
Diferencias de los síntomas psicóticos en la esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo

	Esquizofrenia	Trastorno de identidad disociativo
Alucinaciones	Alucinaciones auditivas principalmente	Alucinaciones auditivas (que reflejan diálogos de las personalidades alternativas, descritas como pensamientos más que como voces), visuales, olfativas, táctiles, gustativas y cenestésicas
Delirios	Delirios de contenido variado, incluyendo percepción y ánimo delirante	Delirio de varias personalidades, de cambio entre ellas y de control
Delirios de control o experiencias de pasividad (pensamiento, afecto, voluntad, cuerpo)	Atribuidos a terceras personas; frecuente la difusión, lectura, robo e inserción del pensamiento	Atribuidos a las personalidades alternativas; infrecuente la difusión, lectura, robo e inserción del pensamiento
Trastornos formales del pensamiento (desorganización del pensamiento)	Presentes	Ausentes, aunque el cambio entre personalidades o la amnesia pueden simular bloqueos
Juicio de realidad	Alterado	Conservado la mayor parte del tiempo
Síntomas disociativos	Aislados, acompañando a síntomas psicóticos Despersonalización sobre todo en las fases iniciales	Recurrentes y persistentes Despersonalización y amnesia disociativa
Respuesta a antipsicóticos	Significativa	Escasa

Adaptada de Moskowitz A, et al²⁷.

cientes con TID cumplen a su vez criterios para TEPT¹⁸. La diferencia principal entre ambos es que, en el caso de este último, los síntomas se centran en el evento traumático, mientras que en el TID no siempre ocurre así.

El subtipo disociativo de TEPT se manifiesta con síntomas de despersonalización-desrealización.

Trastorno facticio y simulación

En los pacientes simuladores se identifican incentivos externos (económicos o jurídicos), no siendo necesario en el caso del trastorno facticio, en el que el objetivo es la adquisición del papel de enfermo.

Los fingidores suelen crear identidades alternativas caricaturizadas y relacionadas con los hechos por los que se busca la ganancia. Además, muestran normalmente poca repercusión emocional y puede incluso parecer que disfrutan de padecerlos, presentándose a los demás como enfermos, discapacitados o víctimas, con un relato de los síntomas exagerado y abigarrado. Las personas con un verdadero trastorno disociativo tienden a avergonzarse y verse sobrepasados por sus síntomas, tendiendo a la minimización y la ocultación de los mismos¹.

Tratamiento

Psicoeducación

La psicoeducación es muy recomendable en estos trastornos. Se debe dar información sobre la naturaleza de los síntomas, aportando seguridad y tranquilidad, refutando los miedos del paciente «a estar volviéndose loco» o a «sufrir un daño cerebral permanente». Hay que explicarles que los síntomas somáticos tienen un origen psicológico³¹. También es importante aliviar los sentimientos de vergüenza y culpa que sufren, al verse descalificados por el entorno que pone en dudas la verosimilitud y proporcionalidad de los síntomas³².

Psicoterapia

La base del tratamiento es la psicoterapia, aunque cuenta con escasa y débil evidencia. Además, no existen estudios comparativos de la eficacia de las distintas técnicas para estos trastornos^{27,31,33}.

Psicofármacos

No existe evidencia sólida de la eficacia de ningún tratamiento farmacológico sobre los trastornos disociativos. Además, la respuesta de los fármacos es parcial, demorada e incluso paradójica, lo que hace que debamos ser muy prudentes a la hora de introducir cualquier fármaco o de aumentar dosis.

Se emplean psicofármacos con los siguientes objetivos:

1. Obtener información de hechos que permanecen fuera de la memoria consciente. Clásicamente se empleaba amobarbital, tiopental, anfetaminas y benzodiazepinas.

2. Estabilización de los síntomas que permita iniciar una psicoterapia posterior.

3. Tratamiento de los síndromes comórbidos^{27,33,34}.

Trastorno de despersonalización-desrealización

Se utilizan diversos tipos de psicoterapia, recomendándose (sin evidencia sólida) comenzar por la terapia cognitivo-conductual³⁵.

Aparte del tratamiento de las comorbilidades, para los síntomas propios del trastorno se emplean los siguientes fármacos, aunque sin contar con una evidencia sólida: naltrexona (para el embotamiento afectivo), estimulantes (metilfenidato, bupropión, atomoxetina, modafinilo y donepezilo) y lamotrigina³⁴.

Amnesia disociativa

No se describe tratamiento específico. Las recomendaciones son similares a las del TID³³.

Trastorno de identidad disociativo

El objetivo del tratamiento es el funcionamiento integrado.

La identidad que tiene el control, por lo general, habla en primera persona y puede conocer algunas de las otras partes o desconocerlas por completo. El núcleo del proceso terapéutico es ayudar a las identidades a reconocerse mutuamente como partes legítimas del yo y a negociar y resolver sus conflictos.

El resultado del tratamiento más deseable es la fusión final de todos los estados de identidad. Sin embargo, incluso después de someterse a un tratamiento prolongado, un número considerable de pacientes con TID no podrá lograrla. Un resultado más realista a largo plazo para algunos pacientes puede ser un acuerdo cooperativo entre las identidades alternativas para promover un funcionamiento óptimo.

Enfoque del tratamiento orientado en fases

En las últimas dos décadas, el consenso de los expertos es que los trastornos complejos relacionados con el trauma, incluido el TID, se deben tratar en etapas secuenciales.

Fase 1: establecimiento de seguridad, estabilización y reducción de los síntomas. Se pueden utilizar estrategias como la autohipnosis o los fármacos para conseguir la estabilización.

Fase 2: confrontar, trabajar e integrar memorias traumáticas. Como resultado, la memoria traumática debe convertirse en memoria narrativa.

Fase 3: integración y rehabilitación. Se trata de lograr una narrativa coherente y que permita al paciente centrarse menos en el pasado y más en el presente y futuro²⁷.

Psicoterapia

Lograr estos objetivos se suele hacer empleando la psicoterapia individual ambulatoria a largo plazo. No cabe esperar mejoría antes de años.

La técnica más recomendada es la psicoterapia individual de orientación psicodinámica, aunque aplicada de forma ecléctica, permitiendo el empleo de otras técnicas como la cognitivo-conductual para el manejo de cogniciones distorsionadas en respuesta al estrés, al trauma o para el control de impulsos; hipnosis para tranquilizar, contener y fortalecer el ego; familiar, dialéctica conductual, entre otras.

También se emplea la terapia EMDR (desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares), una psicoterapia empíricamente validada para el tratamiento de secuelas psicológicas de eventos traumáticos. Recibe su nombre de una de sus fases, en la que se recuerda el suceso traumático mientras se lleva a cabo una estimulación bilateral, principalmente en forma de movimientos oculares alternantes³⁶.

Estas técnicas deben ser modificadas para tratar a pacientes con TID, para evitar su desestabilización al provocar memorias emergentes o emociones muy intensas.

Aunque la terapia se realiza de forma ambulatoria, pueden existir crisis con riesgo de autoagresividad o heteroagresividad que requieren un internamiento en unidades de agudos hasta que se logre la estabilización y desaparición del riesgo³⁷.

Psicofármacos

No se consideran un tratamiento primario de elección. Ninguno es curativo. Las guías no aportan recomendaciones específicas, ya que son necesarios más estudios de investigación.

Sin embargo, es muy frecuente que se utilicen los psicofármacos como tratamiento de algunos síntomas y de los trastornos comórbidos.

Las personalidades alternativas pueden presentar diferentes respuestas a la medicación, debido a los diferentes niveles de activación, de estado de ánimo y de síntomas. El tratamiento farmacológico debe orientarse a aquellos síntomas que se manifiestan en todas las identidades y no a los que aparecen de forma esporádica o fluctuante por intrusión de identidades alternativas.

La depresión comórbida debe ser tratada con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o duales. Hay que recordar que las fluctuaciones anímicas no responderán a los estabilizadores del ánimo. Solo estarían indicados si se demuestra comorbilidad con trastorno bipolar.

Las alucinaciones y delirios no responden bien a los antipsicóticos, aunque, ocasionalmente, pacientes crónicos con gran desorganización, refractarios a otros antipsicóticos, pueden responder favorablemente a dosis bajas de clozapina.

Naltrexona se ha mostrado eficaz para el tratamiento de conductas autolesivas en estos pacientes¹⁸.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. ●● American Psychiatric Association. **Diagnostic and statistical manual of mental disorders**. 5ª ed. Arlington: American Psychiatric Association; 2013.
2. World Health Organization. **The ICD-10 Classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines**. Ginebra: World Health Organization; 1992.
3. ● Loewenstein RJ. **Dissociation debates: everything you know is wrong**. *Dialogues Clin Neurosci*. 2018;20(3):229-42.
4. Brown RJ. The cognitive psychology of dissociative states. *Cogn Neuropsychiatry*. 2002;7(3):221-35.
5. Sar V. Epidemiology of dissociative disorders: an overview. *Epidemiol Res Int*. 2011;2011:8.
6. Cardena E. The domain of dissociation. En: Lynn SJ, Rhue RW, editors. **Dissociation: theoretical, clinical, and research perspectives**. New York: Guilford; 1994.
7. ● Sar V, Dorahy MJ, Krüger C. **Revisiting the etiological aspects of dissociative identity disorder: a biopsychosocial perspective**. *Psychol Res Behav Manag*. 2017;10:137-46.
8. Spiegel D, Loewenstein RJ, Lewis-Fernández R, et al. Dissociative disorders in DSM-5. *Depress Anx*. 2011;28(9):824-52.
9. Sar V, Yargic LI, Tutkun H. Structured interview data on 35 cases of dissociative identity disorder in Turkey. *Am J Psychiatry*. 1996;153(10):1329-33.
10. Krüger C, Fletcher L. Predicting a dissociative disorder from type of childhood maltreatment and abuser-abused relational tie. *J Trauma Dissociation*. 2017;18(3):356-72.
11. ●● Byun S, Brumariu LE, Lyons-Ruth K. **Disorganized attachment in young adulthood as a partial mediator of relations between severity of childhood abuse and dissociation**. *J Trauma Dissociation*. 2016;17(4):460-79.
12. Bowlby J. **Attachment and Loss**. New York, NY: Basic Books; 1969/1982.
13. Sar V, Alioglu F, Akyüz G. Depersonalization and derealization in self-report and clinical interview: the spectrum of borderline personality disorder, dissociative disorders, and healthy controls. *J Trauma Dissociation*. 2017;18(4):490-506.
14. Porges SW. **The polyvagal theory: neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation**. New York, NY: Norton; 2011.
15. Elbert T, Schauer M. Dissociation following traumatic stress. *J Psychol*. 2010;218(2):109-27.
16. Prebble SC, Addis DR, Tippet LJ. Autobiographical memory and sense of self. *Psychol Bull*. 2013;139(4):815-40.
17. Putnam FW. **The way we are. How states of mind influence our identities, personality and potential for change**. Los Gatos, CA: International Psychoanalytic Books; 2016.
18. ●● Foote B. **Dissociative identity disorder: epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis**. UpToDate 2018. Disponible en: www.uptodate.com [Consultado enero 2019].
19. Krause-Utz A, Frost R, Winter D, Elzinga BM. Dissociation and alterations in brain function and structure: implications for borderline personality disorder. *Current Psychiatry Reports*. 2017;19(1):6.
20. ● Sar V. **The many faces of dissociation: opportunities for innovative research in psychiatry**. *Clin Psychopharmacol Neurosci*. 2014;12(3):171-9.

21. ● Loewenstein RJ. Dissociative amnesia: epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, and diagnosis. UpToDate 2018. Disponible en: www.uptodate.com [consultado enero 2019].
22. Nakatani Y. Dissociative disorders: from Janet to DSM-IV. *Seishin Shinkeigaku Zasshi*. 2000;102(1):1-12.
23. Richard P. Reconsidering hypnosis and psychoanalysis: toward creating a context for understanding. *Am J Clin Hypn*. 2018;60(3):201-15.
24. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3ª ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1980.
25. Morrison J. DSM-5. Made Easy. The clinician's guide to diagnosis. New York: The Guilford Press; 2014.
26. Spiegel D. Dissociation in the DSM5. *J Trauma Dissociation*. 2010;11(3):261-5.
27. ●● International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Guidelines for treating dissociative identity disorder in adults, third revision. *J Trauma Dissociation*. 2011;12(2):188-212.
28. Luque-Luque R, Chauca-Chauca GM, Alonso-Lobato P, Jaen-Moreno JM. Despersonalización y esquizofrenia: estudio comparativo entre primeros y múltiples episodios de esquizofrenia. *Rev Psiquiatr Salud Ment (Barc.)*. 2016;9(3):143-9.
29. Oyebo F. Sims' Symptoms in the mind. 5th ed. London: Elsevier; 2015.
30. Skodol A. Borderline personality disorder: Epidemiology, clinical features, course, assessment, and diagnosis. [Monografía en Internet]. Waltham (MA): UpToDate 2017. Disponible en: www.uptodate.com [Consultado enero 2019].
31. Simeon D. Psychotherapy of depersonalization/derealization disorder. UpToDate 2017. Disponible en: www.uptodate.com [Consultado enero 2019].
32. Soler PA, Gascón J. RTM IV. Recomendaciones terapéuticas en los trastornos mentales. Madrid: Comunicación y Ediciones Sanit; 2012.
33. ● Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwe; 2015.
34. Simeon D. Pharmacotherapy of depersonalization/derealization disorder. UpToDate 2018. Disponible en: www.uptodate.com [Consultado enero 2019].
35. Simeon D. Approach to treating depersonalization/derealization disorder. UpToDate 2017. Disponible en: www.uptodate.com [Consultado enero 2019].
36. Shapiro F. The Role of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy in medicine: addressing the psychological and physical symptoms stemming from adverse life experiences. *Perm J*. 2014;18(1):71-77.
37. Moskowitz A, Schäfer I, Dorahy MJ. Psicosis, trauma y disociación. Madrid: Fundación para la investigación y el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos; 2011.